

四、异常分娩对高热惊厥的影响:77例高热惊厥患儿中剖腹产18例,占23.3%,复发8例,占复发病例的8/43,钳产或胎吸10例,占11.7%,复发10例,有窒息史21例占28.6%,复发18例。顺产28例占36.4%,复发11例。

讨 论

统计1991年元月至1992年12月二年中77例高热惊厥患儿由其一般资料来看,男孩发病多于女孩,约为1.6:1,接近1981年左启华主编的《小儿神经系统疾病》一书中高热惊厥一章中有关统计资料,本组也以6月~2 $\frac{1}{2}$ 岁小儿为发病高峰期。由围产期情况分析,出生体重及胎龄在高热惊厥患儿中对其发病率及复发率无显著差别,而异常分娩对高热惊厥的发病率及复发率影响较大,其中有窒息史患儿其发病率及复发率占首位,复发率为顺产儿的2倍($P<0.5$),其次为钳

产或胎吸,剖腹产的复发率占比例也较大,考虑与分娩前有宫内窘迫有关。综上所述:由于早期新生儿神经系统发育不完善、异常分娩时所造成的缺氧、缺血对脑细胞损伤很大,如完全断氧可对脑细胞造成不可逆的损伤。而婴幼儿的大脑发育未成熟,免疫机能低下,易受细菌或病菌感染造成发热,可能在此诱因下异常分娩的小儿由于产时对脑细胞所造成的损伤使其比正常产儿易出现惊厥,从而加重脑缺氧,导致惊厥复发。如惊厥时间长或短期内反复多次高热惊厥发作转为癫痫的比例越大,可能影响患儿智力发育。故提高产科技术,做好围产期保健,以减少围产高危因素是很重要的,对有围产高危因素的患儿要加强护理及责任心,预防感染发生,如一旦有高热惊厥史,一定要及时发现及早治疗,积极防止高热惊厥的复发。

1996-07-06

抗肿瘤与抗菌药物相互作用之临床观察

一附院外科 郭予秋 欧阳军 丁 伟

抗菌药物除本身用药外,尚存在着与抗肿瘤药物同时使用相互影响问题。我们对205例住院病例进行抗菌药物应用及部分与抗肿瘤药物同时使用问题,进行随机调查与分析,得出如下结果:抗菌素临床使用率79%(162例);发现除单独应用抗菌药时用药欠妥外,尚存在两者合用产生的各种药理及临床效应问题。他们能影响各自的治疗效果,本文特对这些问题进行总结分析,以求今后更合理的用药。

结果与讨论

一、用量过大:主要表现在使用氨基甙类抗菌药物中,如庆大霉素(使用者40例),一日静滴量均在32万单位以上;其中肿瘤病人就占66.9%,肿瘤病人多数年龄在50岁以

上,用药量过大,用药时再长,易增加肾的损害率。本组40例中27例肿瘤病人,用药前尿检正常者21例,其中用庆大霉素者17例,用后尿检不正常者13例,提示有不同程度肾损害。

二、抗肿瘤药物与抗菌药物同时使用,可产生多种药理及临床效应,可改变各自治疗效果。因为有时与病情交织在一起,不易被察觉,造成识别时的困难。如:患者,男,56岁,胃癌行全切除术,术后恢复顺利,切口一期愈合,但体温始终38℃以上,食欲渐差,后发现化疗药与抗菌药合用,遂停用抗菌药物,单用抗肿瘤药物,病情迅速好转,体温降至正常,现正健在5年,并多次住院化疗。

三、住院病人中26例乳癌患者术前后曾

用氨甲喋呤(MTX)化疗,但由于感染等问题同时又用青霉素及庆大霉素。查阅病历中9例(35%)用药前尿检正常。用药后尿检有蛋白、红血球或管型。说明二者之间相互作用可增加毒性,主要影响MTX在胃肠道内吸收、蛋白质结合率及消除过程,且二者在肾小管

内竞争排出,可使血内MTX的浓度升高、同时MTX在体内蓄积时间延长,不仅可使毒性增加,而且可使肾功能受损害,因此对这样用药情况今后应尽量注意避免。

1996-07-10

非胰岛素依赖性糖尿病血糖与胰岛素水平的同步测定研究

石河子大学医院 舒 艳
石河子人民医院 雷 英

传统的观念认为,非胰岛素依赖性糖尿病(NIDDM)的病因主要是胰岛素分泌相对不足所致,但近年来的研究,越来越多的学者把胰岛素抵抗提到了一个重要的位置,并成为人们研究的热点,故此,我们在临床中对非胰岛素依赖性糖尿病患者重点作了血糖与胰岛素浓度水平的测定,以探讨胰岛素与NIDDM的关系。

研究对象与方法

1 研究对象

1.1 糖尿病组:符合WHO诊断标准的NIDDM患者18例(男11例,女7例)。年龄44~62岁,选病例均经详细问诊、体格检查及必要的实验室检查,以明确诊断。测定前至少两周未用过干扰胰岛素分泌及血糖的药物。

1.2 正常对照组:选择无糖尿病史的体检者17例(男13例,女4例),年龄50~63岁。

2 研究方法:口服葡萄糖耐量试验(75g):按空腹(0分钟),餐后30分钟,60分钟,120分钟四次取血样分别作血糖、胰岛素测定,采用双抗——PEG法,药盒为中国原子能科学研究所制。

3 统计方法:全部数据以均数+标准差(X+S)表示,组间均数的比较,采用t检验。

结 果

所有测定数值见附表,两组比较,空腹及餐后各时限血糖有显著差异($P<0.01$),而胰岛素浓度仅空腹时与对照组有显著差异($P<0.05$)。

附表 两组糖耐量试验血糖、胰岛素结果

	正常组(17例)		糖尿病组(18例)	
	血糖(mmol/L)	胰岛素(mu/L)	血糖(mmol/L)	胰岛素(mu/L)
0分钟	5.16±0.85	15.59±4.55	9.66±3.18**	76.38±17.51*
30分钟	7.47±1.49	70.68±36.57	15.10±4.56**	48.65±40.26
60分钟	7.59±2.33	98.12±65.00	17.41±4.03**	59.17±48.25
120分钟	5.75±1.16	68.90±60.20	16.76±4.37**	55.42±41.14

注:与正常组比较,* $P<0.05$ ** $P<0.01$